创新药评价的注意力配置差异与协调路径*

王孝炯[1]，陈海婷[1,2]，刘中全[3]

（1. 中国科学院科技战略咨询研究院，北京 100190；
2. 中国科学院大学公共政策与管理学院，北京 100049；
3. 国家发展和改革委员会创新驱动发展中心，北京 100038）

摘要：为比较创新药评价的部门差异，本文基于“制度逻辑—组织注意力”框架，以大语言模型对 4 481 个政策句段进行五维编码，以 466 条人工标注检验编码质量，并结合条文与访谈分析。结果显示，在五维内容构成中，药监局安全性与有效性合计占 68.38%，医保局经济性占 76.48%，卫健委安全性占 39.37%。医保局安全性句段中 81.01%同时涉及有效性，高于另外两部门，与安全有效共同作为目录准入条件的要求相对应。三部门差异还体现在同一维度的评价对象、参照药品与证据要求，评价结论分别服务于上市、支付和临床使用决策。因此，跨部门协调应明确评价结论的适用条件，提前沟通比较药品的选择与证据要求，统筹补充研究，并完善药品配备与使用反馈。

关键词：创新药评价；制度逻辑；注意力配置；大语言模型；政策文本；三医协同

中图分类号：**C934**　　文献标识码：**A**

Differences in Attention Allocation in Innovative Drug Evaluation and Coordination Pathways

WANG Xiaojiong[1], CHEN Haiting[1,2], LIU Zhongquan[3]

(1. Institutes of Science and Development, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China;
2. School of Public Policy and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;
3. Innovation-driven Development Center, National Development and Reform Commission, Beijing 100038, China)

Abstract: This study examines departmental differences in innovative drug evaluation through institutional logics and organizational attention. It uses large language models to code 4 481 policy passages across five dimensions, assesses coding quality against 466 human-annotated passages, and interprets the findings through policy provisions and interviews. Within the five-dimensional content distribution, safety and efficacy together account for 68.38% in drug regulatory policy, economic value for 76.48% in medical insurance policy, and safety for 39.37% in health administration policy. Among safety-related passages in medical insurance policy, 81.01% also address efficacy, a higher proportion than in the other two systems. This pattern corresponds to safety and efficacy being joint requirements for reimbursement-list inclusion. Differences also concern the populations, comparators and evidence requirements within the same evaluation dimension, with conclusions serving marketing authorization, reimbursement and clinical use decisions. Coordination should clarify the conditions under which conclusions apply across stages, discuss the choice of comparator medicines and evidence requirements early, coordinate supplementary studies and improve feedback on medicine availability and use.

Key words: innovative drug evaluation; institutional logics; attention allocation; large language models; policy text; coordination of healthcare, health insurance and pharmaceuticals

---

*基金项目：国家自然科学基金项目（72074204）。

作者简介：王孝炯（1982—），男，安徽合肥人，中国科学院科技战略咨询研究院研究员。主要研究方向：创新发展政策。

陈海婷（2002—），女，福建建瓯人，中国科学院科技战略咨询研究院、中国科学院大学公共政策与管理学院硕士研究生。主要研究方向：科技创新管理与政策。

刘中全（1988—），男，河南周口人，国家发展和改革委员会创新驱动发展中心副研究员。主要研究方向：科技政策、生物经济。

1 引言

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》[1]提出健全医疗、医保、医药协同发展和治理机制，优化创新药审评审批，并健全医保支持创新药的机制。2025 年《支持创新药高质量发展的若干措施》[2]推动研发、准入与使用衔接；同年发布的首版商业健康保险创新药品目录自 2026 年 1 月起实施[3]。在创新药从获批上市到支付准入、临床使用的过程中，各环节如何理解和使用已有评价结论，成为政策协调的重要问题。

上述政策为跨环节衔接提供了制度安排，但不同部门对创新药的评价并不完全相同。一款创新药从获批上市、纳入医保到临床使用，涉及国家药品监督管理局（以下简称药监局）、国家医疗保障局（以下简称医保局）、国家卫生健康委员会（以下简称卫健委）的管理职责和评价安排，各环节的评价目的与参照对象各有侧重。课题组的专家访谈显示，获批上市的 1 类创新药，未必能够满足医保局对临床价值的评审要求；纳入医保目录的药品，在医疗机构实际使用中仍可能面临障碍。因此，有必要进一步明确各环节评价所要解决的问题，以及评价结论可供其他环节参考的范围。

本文从两个层面比较三部门的创新药评价：一是根据安全性、有效性、经济性、创新性、公平性的注意力占比，考察各部门政策文本的关注重点；二是结合政策条文与访谈资料，比较同一维度下的评价对象、参照药品和决策用途。前者比较各部门对五维评价内容的关注比重，后者考察已有评价结论在后续环节的使用条件。

本文以“制度逻辑—组织注意力”为分析框架，对三部门 2017—2026 年的 51 项政策资料进行编码，并结合条文、访谈与国际研究，分析评价要求的差异及部门间的协调路径。

2 文献综述

2.1 创新药多维评价的研究脉络

在评价标准与准入机制方面，孔繁翠[4]比较英、德、法、加四国的创新药价值评估制度，建议建立附加临床收益评估及分级体系；赵华婷等[5]借鉴法国经验，建议以临床价值分级及再评价支持医保目录动态调整。艾丹丹等[6]讨论价值评估的多维属性，强调以公开透明的评价标准支持基于价值的定价和支付。

在主体互动方面，王恩楠等[7]通过演化博弈模型分析谈判策略，并结合三种谈判药品的销售资料进行比较。在政策工具层面，吕倩鹏等[8]对65份国家层面创新药研发政策的量化分析发现，政策工具的内部结构存在失衡。

国际研究表明，比较不同机构的评价结论时，需要区分其评价标准与证据要求。Casilli等[9]以2017年7月至2022年12月在意大利申请创新性认定的189个药品/适应症为样本，比较法、德、意三国健康技术评估（Health Technology Assessment，HTA）结论：德法一致率为82%，意法和意德分别为52%和57%；次级分析纳入意大利创新性认定中的证据质量因素后，意法和意德的一致率分别升至72%和74%。Garau等[10]对意大利19名患者代表、临床医生和支付方人员开展探索性研究，发现患者代表较重视疾病严重性与治疗获益类型，临床医生较重视疾病严重性与比较疗效，支付方人员较重视未满足需求、比较成本及证据质量。

2.2 多主体评价差异的既有研究

Kållberg等[11]围绕抗生素研发与评价，收集了欧洲及美国药品监管和HTA机构19名参与者的访谈或书面答复。研究发现，受访者对新颖性的理解涉及新类别中的首个抗生素、无已知耐药机制等不同标准；临床数据有限，也给上市评价、HTA与临床使用之间的证据衔接带来困难。Mundy等[12]基于Health Technology Assessment international（HTAi）亚洲政策论坛背景论文与讨论指出，HTA对创新的定义和评价并不一致，创新因素往往隐含在优先排序及药品定价、报销决策之中。

在国内研究中，李梦颖等[13]运用制度逻辑理论分析医保谈判药品在医疗机构的配备与使用问题，讨论国家逻辑、市场逻辑、社会逻辑和专业逻辑之间的冲突与联系。本文关注药品监管、医保准入和临床使用中的评价判断，重点考察各环节的评价内容、参照对象和证据用途，并结合政策条文及其适用条件加以分析。

2.3 既有研究与本文定位

已有研究从政策工具视角比较医保局与卫健委的政策文本[14]，并梳理健康技术评估在医保目录调整中的应用[15]。本文在统一的五维框架下，比较三部门政策文本的关注重点及不同维度同时出现

的情况，再结合具体条文分析评价对象、参照药品、证据要求与结论用途。由此考察部门关注差异与评价任务的关系，并明确已有评价结论用于后续环节时需要满足的条件。

3 理论基础与分析框架

3.1 核心概念与理论逻辑

政府注意力研究通过正式政策文本的内容选择，考察组织关注的重点[16]。文宏[17]通过关键词所在句段及其语境测量基本公共服务注意力；陈星平等[18]按同一句段在同一维度计一次、在不同维度分别计数的原则，比较关注内容的构成；练宏[19]讨论组织与制度环境对注意力配置的影响。本文将“注意力配置差异”界定为三部门对五维评价内容的关注比重差异，以“注意力占比”衡量，即某维度编码为 1 的句段数占该部门五个维度编码为 1 的句段数之和的比例。同一句段可计入多个维度，在同一维度至多计一次，五维注意力占比合计为 100%。

Thornton 等[20]的制度逻辑视角强调实践、价值和规则与认知、行动及制度环境之间的联系；Greenwood 等[21]讨论组织如何回应多重制度要求。本文据此考察药品注册、医保准入和临床使用各自的决策目标，并比较这些目标在评价对象、证据要求和结论用途上的具体体现。

Ocasio[22]的注意力基础观认为，组织决策与其关注的议题及应对方案有关，注意力配置则受情境、规则、资源和关系等因素影响。李梦颖等[13]将制度逻辑与医药政策主体的注意力配置联系起来。本文据此考察三部门政策文本关注哪些评价内容，再结合条文与访谈分析这些关注与决策任务的关系。注意力占比用于衡量政策文本中的关注结构；实际评审中各维度的权重，则需依据相应的决策资料分析。

3.2 三种制度逻辑的操作化

借鉴李梦颖等[13]的医药政策分析，本文根据三部门核心文件的政策目标概括其制度逻辑。《药品注册管理办法》[23]要求保证安全、有效和质量可控，并明确临床价值导向，对应科学—安全逻辑；《基本医疗保险用药管理暂行办法》[24]（以下简称《暂行办法》）要求提高基金使用效益，将临床必需、安全有效、价格合理列为目录准入条件，对应经济—效率逻辑；《药品临床综合评价管理指南（2021 年版 试行）》[25]（以下简称《管理指南》）强调保障基本用药供应、规范使用及满足用药

需求，对应公共服务逻辑。本文以这三种逻辑为比较依据，安全有效和临床价值则是三部门共同关注的基础（表 1、图 1）。

表 1 创新药评价中的三种制度逻辑

Table 1 Three Institutional Logics in Innovative Drug Evaluation

制度逻辑	对应部门	政策目标	评价要求	比较问题
科学—安全逻辑	药监局	保证安全、有效 和质量可控	以临床价值为导向； 提供相应证据	证据如何支持 上市决策
经济—效率逻辑	医保局	提高基金使用效益	临床必需、安全有效、 价格合理	评价结论如何用于 准入和支付
公共服务逻辑	卫健委	保障供应、规范使用， 满足用药需求	安全性、有效性、经济性、 创新性、适宜性、可及性	综合评价如何 指导临床使用

资料来源：作者整理。

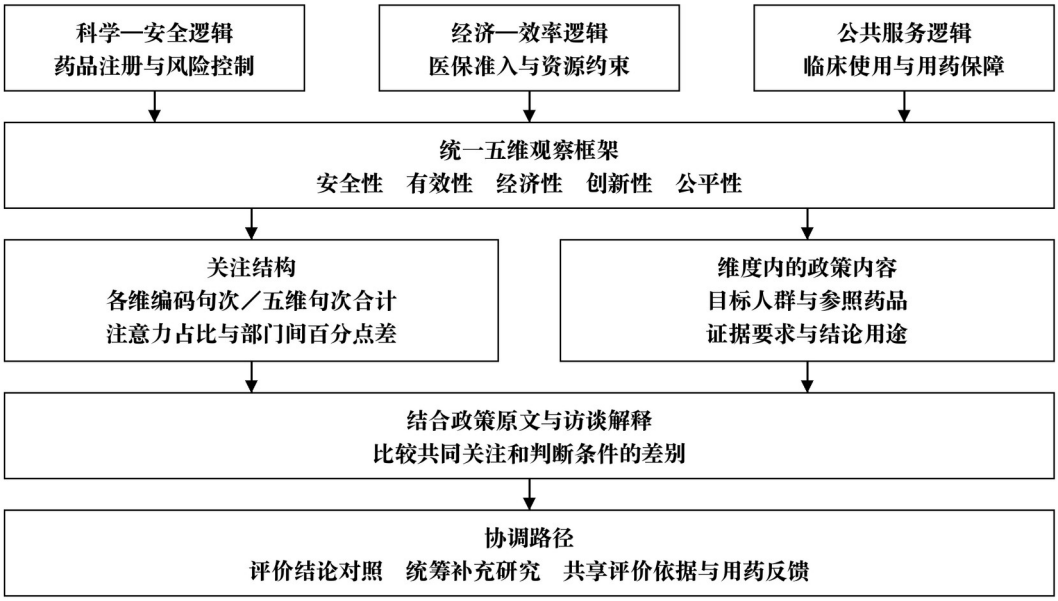


图 1 “制度逻辑—组织注意力”分析框架

Figure 1 The “Institutional Logics–Organizational Attention” Framework

资料来源：作者绘制。

3.3 变量与指标定义

本文将安全性、有效性（疗效与临床获益）、经济性、创新性、公平性分别记为 S、E、Ec、I、F，在句段层面逐维编码：符合该维定义记为 1（正类），不符合记为 0，信息不足而无法判断时保留待定；同一句段可以涉及多个维度。五维的含义及纳入、排除条件见第 4.1 节和补充材料 A。

注意力占比按第 3.1 节定义计算；内容覆盖比例以部门全部句段数为分母，衡量涉及某维度的句段占比。前者五维合计为 100%，后者因同一句段可涉及多个维度，合计不必为 100%。条件比例衡量涉及某一维度的句段中，同时涉及另一维度的比例。例如，安全性句段中同时涉及有效性的比例，以两维均判为 1 的句段数为分子，以安全性判为 1 且有效性可判定的句段数为分母。各项指标均依据 4 481 条全量编码计算，待定项单独保留。

4　研究设计

4.1　政策文本与编码方案

研究范围为 2017 年至 2026 年 7 月公开的药品评价政策及配套官方材料。2017 年，人力资源社会保障部组织药品谈判并将 36 种药品纳入医保目录乙类范围[26]，本文以此次医保谈判准入为研究起点。

参考吕倩鹏等[8]的政策筛选方法，收集药品监管、医疗保障和卫生健康系统的正式文本，剔除纯药品清单、年度审评报告、按疾病诊断相关分组和按病种分值付费的技术规范、逐年临床用药手册，以及已有正式版的征求意见稿。三部门比较共纳入 51 个来源条目，其中药监局 17 个、医保局 24 个、卫健委 10 个；党中央、国务院或中共中央办公厅与国务院办公厅发布的 4 份文件作为共同制度背景。一个来源条目可以包括通知、附件或配套官方问答，同一正文重复发布时只计一次。联合发文按既定的制度系统归属计入一个部门，并通过剔除联合文本检验这一处理对结果的影响。

本文采用医保目录调整中的安全性、有效性、经济性、创新性、公平性五维框架进行比较。《目录调整申报指南》[27]要求按这五个维度组织材料，2023—2026 年沿用相同的维度名称，并对具体要求作出调整；《常用问答（2026 年版）》[28]也要求从多个维度综合研判药品价值。各维申报内容依次涉及安全性信息、不良反应及同类药比较，疗效比较与指南推荐，价格费用及基金影响，创新点、临床优势、知识产权与注册分类，以及目录短板、临床管理难度等。公平性栏目还要求目录外药品提供价格费用信息，说明政策栏目的划分并不意味着研究中的各类内容相互排斥。因此，编码以句段的实质内容和统一操作定义为依据。

五维框架用于统一比较尺度，具体编码仍取决于句段表达的内容。《管理指南》[25]原设安全性、有效性、经济性、创新性、适宜性、可及性六个维度；其中涉及药品获取保障和可负担性的内容归入本研究的公平性，适宜性则按原政策含义解释。医保公平性栏目中的价格信息，按费用内容编码为经济性；若同时涉及患者负担或药品获取保障，则另记为公平性。各维度的纳入、排除及多标签编码规则见补充材料 A。

本文采用自动规则编码与大语言模型（Large Language Model，LLM）编码处理全部文本。自动规则编码结合领域词典和语境规则，判断表述是否针对药品，辨明适用范围、上级条款及否定关系；LLM 编码依据完整手册，结合待编码句段和必要上下文给出五维判断及原文依据。词典分类的质量检验参照 Kroon 等[29]，LLM 编码参照 Gilardi 等[30]及 Halterman 等[31]。两种方法使用同一版政策原文及必要上下文，遵循相同的五维定义和纳入、排除条件。两种方法均与同一批人工标注结果比较，依据第 4.2 节的检验确定主要分析方法。

本文以具有完整政策含义的句段为分析单元，并保留上级条款、表头及前后文，以确定表述对象和适用条件。三部门共 4 481 个分析单元，其中药监局 1 848 个、医保局 2 100 个、卫健委 533 个。采用多标签编码：五个维度分别作 0/1 判断，信息不足者保留待定；同一句段在同一维度至多计一次，可以同时计入不同维度。例如，“降低患者用药负担”既涉及费用，也涉及患者可负担性，可同时编码为经济性和公平性；降低企业申报费用则不据此编码为公平性。各维度依据具体含义分别判断，不因出现在同一段落中而一并赋值。注意力占比按第 3.3 节计算，部门差异以百分点表示。

4.2 编码质量检验

人工核验共纳入 466 条句段，包括 166 条重点类别样本，以及从三个部门各随机抽取的 100 条样本，分属药监局 106 条、医保局 202 条、卫健委 158 条。重点类别材料覆盖药监局的经济性内容，以及医保局、卫健委的安全性和公平性内容，以增加对稀少类别及关键组合的核查。人工依据统一编码手册，对照原文及必要上下文逐条确认五个维度，共形成 2 330 项 0/1 人工标签。两种机器方法均与这些人工标签逐项比较，样本构成与抽取范围见补充材料 C。

参照 Grimmer 等[32]关于针对具体研究任务开展验证的原则，以及 Gilardi 等[30]将机器标注与人工标注结果对照的做法，本文按五个维度报告 Cohen κ 系数[33]、精确率（P）、召回率（R）及 F1。κ 衡量扣除机会一致后的判定一致性；P 表示机器判为 1 的句段中有多少得到人工确认，R 表示人工判为 1 的句段中有多少被机器识别，F1 为 P 与 R 的调和均值。分类指标在机器和人工均可作二元判断的项目上计算；机器待定单列，不改记为 0。

表 2 报告 466 条核验样本上的直接对照结果，用于比较两种方法的编码质量并确定主要分析方法。样本兼顾重点类别核查和分部门随机抽查，表中指标描述该样本上的表现，不直接解释为 4 481 条语料的总体准确率。

表 2 两种编码方法与 466 条人工标注结果的比较

Table 2 Classification Metrics against Human-Reviewed Labels for 466 Passages

维度	方法	κ	P	R	F1
安全性	LLM	0.938	0.923	0.992	0.956
安全性	规则	0.706	0.913	0.672	0.774
有效性	LLM	0.960	0.948	0.989	0.968
有效性	规则	0.771	0.983	0.682	0.806
经济性	LLM	0.892	0.864	0.982	0.919
经济性	规则	0.699	0.943	0.629	0.754
创新性	LLM	0.938	0.892	1.000	0.943
创新性	规则	0.982	0.968	1.000	0.984
公平性	LLM	0.880	0.821	0.979	0.893
公平性	规则	0.799	1.000	0.689	0.816
五维合并	LLM	0.926	0.897	0.988	0.940
五维合并	规则	0.765	0.951	0.690	0.799

注：各维均以标签 1 为正类，指标保留 3 位小数。LLM 编码和规则编码分别有 2 322 项、2 251 项有效二元判断，待定 8 项、79 项。五维合并行汇总各维度的真阳性、假阳性、假阴性和真阴性计数，样本仍为 466 条句段。各维度可判定项数、待定项数及分类计数见补充材料 C。

在 466 条核验样本中，LLM 在安全性、有效性、经济性和公平性四个维度的 κ 与 F1 均高于规则编码，创新性则以规则编码略高（表 2）。合并五维后，LLM 的精确率为 89.69%、召回率为

98.79%，规则编码分别为 95.05%、68.97%。规则判为相关内容的句段较多得到人工确认，但遗漏的相关句段也较多；LLM 识别得更完整，同时增加了一些误判。

人工对照有助于辨明两种方法的具体识别差异。例如，抗肿瘤药物研发文件指出，在早期研究的剂量递增阶段，患者可能无法接受充分、有效的治疗；该句在人工标注和 LLM 中记为有效性，规则编码未予识别。另一条要求药品核查、检验机构在审评时限届满前反馈材料，人工标注与规则编码未将一般流程要求记为创新性，LLM 则予以识别。前者是规则编码漏掉了涉及疗效的表述，后者是 LLM 将一般审评程序误判为创新性内容；两种方法采用的维度定义相同。

本研究需要在统一标准下识别政策句段涉及的评价维度，既要减少遗漏，也要控制误判。综合各维度的 κ、F1 及具体判读结果，本文选择 LLM 编码作为部门比较的主要依据。规则编码保留为方法对照，用于检查主要判断是否随编码方法改变。上述差异反映本研究所用规则与 LLM 在该核验样本上的表现。

结合政策原文和访谈，核对句段的评价对象、参照药品和结论用途，区分药品评价要求与一般行政程序[17-18]。

下文表 3 和图 2 依据 LLM 全量编码报告五维评价内容的构成，图 3 报告各维度在部门全部句段中的覆盖比例。来源剔除、统计口径调整和待定项处理用于考察主要结论的稳定性；完整方法对照见补充材料 D、E。

4.3 访谈资料及分析方法

访谈资料包括 3 场企业座谈及专家研讨材料、专家访谈纪要（I01）和医保局调研纪要（I02）。药品监管环节主要依据公开技术文件，研讨会和访谈用于解释评价要求及跨环节实施问题。

按评价对象、证据要求和结论用途整理访谈陈述，并与相应政策条文核对。有关医保准入、药品配备和临床使用的不同意见，分别注明其适用条件。具体引文、日期及出处见配套证据索引。

5 政策文本比较分析

5.1 三部门的注意力配置差异

LLM 全量编码显示，药监局侧重安全性与有效性，两维合计占 68.38%；医保局以经济性为主，占 76.48%；卫健委突出安全用药，安全性占 39.37%（表 3、图 2）。

表 3 三部门五维注意力占比/%

Table 3 Five-Dimensional Attention Shares by Department / %

部门	结果	安全性	有效性	经济性	创新性	公平性
药监局	LLM 全量	40.44	27.94	0.46	20.96	10.20
医保局	LLM 全量	6.97	6.97	76.48	5.84	3.75
卫健委	LLM 全量	39.37	16.54	28.35	3.94	11.81

注：本表为 LLM 全量编码结果。药监局、医保局、卫健委分别有 1 848、2 100、533 条句段。分母为本部门五个维度编码为 1 的句段数之和，未舍入的五维占比合计为 100%。同一句段可涉及多个维度；60 项待定未改为 0。规则对照见补充材料 E。

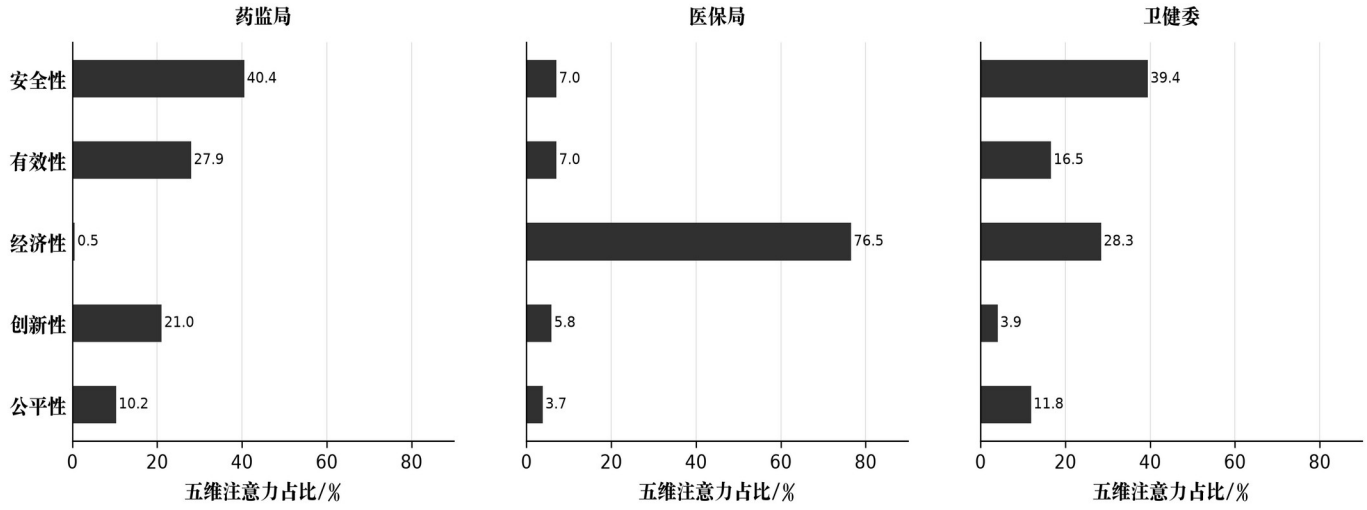


图 2 三部门五维注意力占比

Figure 2 Five-Dimensional Attention Shares by Department

注：本图为 LLM 全量编码结果。分母为各部门五维标签总数，同一句段可计入多个维度；五维合计为 100%。本图反映五维内容的相对构成，数值保留 1 位小数。

规则对照同样显示药监局侧重安全性与有效性、医保局侧重经济性、卫健委突出安全用药。三部门两两比较的 15 项维度占比差异中，13 项方向一致；药监局与卫健委在安全性、公平性上的相对排序随编码方法变化，因此不据此认定两部门在这两个维度上存在稳定的高低关系（补充材料 E）。

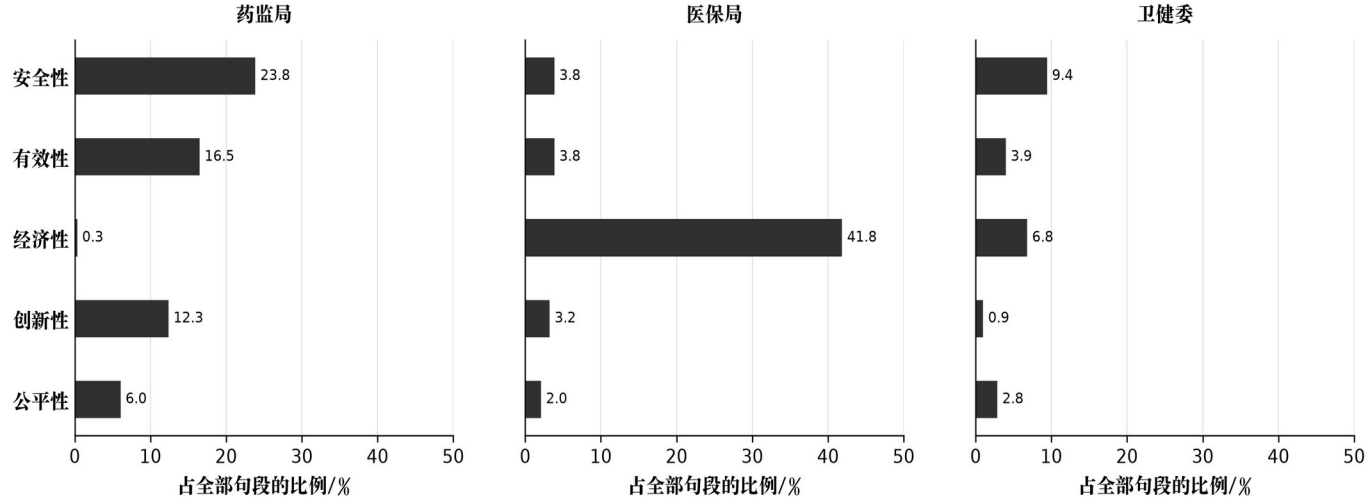


图 3 三部门五维评价内容占全部句段的比例

Figure 3 Proportion of All Passages Addressing Each Evaluation Dimension by Department

注：本图为 LLM 全量编码结果。分母为各部门全部句段数，分子为该维度编码为 1 的句段数。本图反映内容覆盖范围，五维之和不必为 100%；待定项另作边界分析。

两图的差异来自分母。以医保局经济性为例，LLM 识别出 878 条，在全部 2 100 条句段中占 41.81%（图 3）；五维标签合计 1 148 个，经济性占 76.48%（图 2）。前者反映经济性内容的覆盖范围，后者反映其在五维评价内容中的相对比重。LLM 结果在九种统计口径及逐一剔除 51 个来源后的比较中，均保持药监局内部安全性居首、医保局内部经济性居首。卫健委按全部句段统计时以安全性居首，剔除联合来源或 2022 年加强用药安全管理文件后则转为经济性居首，说明其排序受到文件构成的影响（补充材料 D）。

5.2 五维关注的具体政策内容

在经济性句段中同时涉及公平性的比例，卫健委高于医保局。在两维均可判定的材料中，LLM 编码分别为 5/36（13.89%）和 26/877（2.96%）。这一比例说明费用讨论中有多少同时涉及患者获得药品的机会及费用负担。LLM 结果在九种统计口径及逐一剔除来源后均保持上述方向；规则编码在剔除联合来源或 2024 年基层药品联动管理文件后则出现反转（补充材料 D）。因此，该差异反映当前语料中的内容组合，解释时需结合具体政策及其来源构成（表 4）。

若以公平性句段为分母，考察的则是保障内容中有多少同时涉及费用。LLM 编码中，医保局为 26/43（60.47%），卫健委为 5/15（33.33%）。该方向与以经济性为分母的比较不同，因为两种条件

比例的含义不同。政策协调既需要关注费用安排能否回应患者保障问题，也需要明确保障措施涉及哪些费用和支付条件。

表 4 同一评价维度在三部门的具体内容

Table 4 Policy Content within Each Evaluation Dimension across the Three Departments

维度	药监局	医保局	卫健委
安全性	研发和上市环节的药物风险、获益风险评价及控制措施	同类药安全性比较及药品保障渠道中的用药安全	上市前后的安全性证据、处方风险与合理用药
有效性	目标患者的临床获益、试验对照与终点	与试验对照及目录内同领域药品比较，明确支付人群	与参比药比较实际人群的健康获益，必要时开展亚组分析
经济性	真实世界经济学效益评价、试验供药及检测费用的承担	价格、治疗费、支付范围内费用、基金影响与续约	用于采购和临床资源配置的增量经济分析
创新性	创新药注册分类、临床价值导向及研发支持	创新带来的疗效与安全性优势、产品属性变化	临床需求的满足、治疗空白的填补及自主研发
公平性	优先审评临床急需短缺药品，回应供药需求	目录保障短板、患者获取药品的机会及供应、支付条件	机构药品配备、短缺情况、可获得性与家庭可负担性

资料来源：药品注册管理办法[23]、医保用药管理及申报材料[24,27-28]、临床综合评价指南[25]及对应技术文件；各单元格对应的条款、页码与原文证据见配套政策证据矩阵。

药监局有关安全性和有效性的政策内容，主要围绕药品研发及上市所需的获益风险证据展开。《创新药研发期间风险管理计划撰写技术指导原则（试行）》[34]要求识别影响获益风险平衡或受试者安全的风险，并制定预防、监测和治疗措施；抗肿瘤药物研发指南[35]则强调试验对照选择与患者获益终点之间的联系。两种编码方法均显示，药监局经济性的注意力占比较低，其具体内容包括真实医疗实践中的经济学效益评估[36]，以及 2026 年发布的《药物临床试验质量管理规范》[37]第四十五条规定的免费供药及医学检测费用责任。公平性内容则包括《药品注册管理办法》[23]第六十八条对临床急需短缺药品作出的优先审评安排。

医保局的经济性评价涉及药价、治疗费用、销量预测、支付范围和基金影响。《申报指南》[27]要求报告未来两年的销量与基金影响，《谈判药品续约规则》[38]依据实际药品费用与预算的比值安排续约和支付标准调整。2025 年官方问答明确了支付费用监测与药品供应要求，并说明谈判药品的

支付标准包含基金和参保人员共同支付的费用[39]，体现了费用评价与保障安排之间的联系。卫健委《管理指南》[25]将价格水平、可获得性和可负担性共同纳入可及性评价，要求必要时结合医保报销判断患者实际支付水平，并以年用药治疗费用占家庭年可支配收入的比重衡量可负担性；药品监测政策[40]进一步要求共享信息、保障供应并应用评价结果。由此可见，经济性与公平性的联系具体表现为费用分担与支付保障、药品供应和临床使用等问题。

在讨论药品安全性的句段中，医保局更常同时涉及疗效。LLM 编码中，医保局为 64/79（81.01%），药监局为 187/439（42.60%），卫健委为 13/50（26.00%）。这一高低关系在规则对照以及两种方法的九种统计口径、逐一剔除来源和待定值边界分析中均保持不变（补充材料 D）。《暂行办法》第七条将安全有效、临床必需和价格合理共同列为目录准入条件[24]，《申报指南》要求说明创新带来的疗效或安全性优势[27]，医保局调研纪要也将安全性、有效性和经济性列为综合评审的核心内容。安全性在医保局五维内容中的注意力占比虽小，但涉及安全性的句段更常同时讨论疗效，与安全有效共同作为医保准入条件的要求相对应。

5.3 评价依据与参照对象

政策条文与访谈显示，创新药注册分类、临床获益判断和医保支付评价分别服务于不同决策，使用相关结论时需要核对目标人群、参照药品和证据要求。

关于创新性，《化学药品注册分类及申报资料要求》[41]同时考察化合物新颖性和临床价值，《药品注册管理办法》[23]强调以临床价值为导向支持药物创新。医保局的申报材料须说明创新带来的疗效或安全性优势[27]，续约规则则将 1 类药品的注册分类用于特定条件下的谈判选择[38]；《管理指南》[25]通过药品与参比药的比较，考察满足临床需求的程度，并关注治疗空白、未满足需求及自主研发。三部门都重视创新的临床意义，但评价结论分别用于分类注册与研发支持、支付决策或医疗机构的药品遴选与配备。医保局调研纪要指出，获得创新药注册分类并不意味着能够实现企业预期的谈判价格，也说明了这些判断用途的区别。

在有效性和证据要求上，抗肿瘤药物研发指南[35]要求阳性对照反映目标患者在临床实践中的最佳治疗选择；医保局《申报指南》[27]要求比较试验对照药品及目录内同治疗领域药品，《常用问

答》[28]进一步明确，参照药原则上应为临床应用最广泛的同治疗领域、同作用机制的目录内药品；《管理指南》[25]重视参比药、最佳可得研究证据及真实世界数据，必要时开展亚组分析。因此，使用既有研究结果时，应在同一人群和治疗线别下，核对试验对照、医保参照药和临床参比药的异同及适用条件，据此判断原有证据能否直接使用，或是否需要补充比较。

在价值衡量上，药监局通过获益风险判断支持上市审批和风险控制，医保局通过相对临床价值、药品费用及基金影响评估支持医保准入与支付，卫健委则通过安全性、有效性及增量经济分析支持医疗机构的药品遴选、采购使用和资源配置[23-25]。受访专家（I01）强调，医保评审应从健康需求出发；医保局调研纪要也讨论了临床价值分层与经济评价的衔接。结合政策条文可见，经济评价方法虽可用于不同环节，但各项评价仍需分别说明分析视角、成本范围、适用人群和评价结果服务的决策。

5.4 制度逻辑的解释

从制度逻辑看，药监局的科学—安全逻辑体现为研发和上市环节对获益风险及证据充分性的重视；医保局的经济—效率逻辑体现为公共支付中对相对临床价值与资源约束的关注；卫健委的公共服务逻辑则体现为对安全合理用药、药品供应和临床需求的重视。五维注意力占比反映各部门的关注重点；安全性与有效性、经济性与公平性在同一句段中出现的情况，结合准入、支付和供应条文，则有助于说明不同评价要求如何共同服务于具体决策。

从注意力基础观看，三部门都关注安全性、有效性及临床价值，各类内容所占的比重及其组合也随决策任务有所不同。医保局的申报要求引用药审技术评审报告[27]，说明上市审评证据可以为后续评价提供依据；卫健委同时评价价格与药品获取情况[25]，将支付条件、医疗机构配备和临床使用联系起来。2025 年 6 月 9 日的专家访谈纪要（I01）记载的“医保进了，医院不一定用”，也说明药品纳入医保后，仍需解决进入医疗机构和用于临床的问题。

因此，跨部门协调需要明确评价结论的适用条件：针对同一人群核对参照药品，说明已有证据能够回答哪些问题，并共享支付范围、患者负担、医疗机构配备和实际使用信息。后续环节据此判

断哪些结论可以直接参考、哪些问题需要补充研究；支付和临床使用中的反馈，则可为下一轮评价提供依据。

6 协调路径与政策建议

针对评价结论的适用条件及支付、供应和临床使用的衔接问题，结合现有制度安排，提出以下建议。

6.1 提前明确比较药品和证据要求

三部门都关注临床价值，但试验对照药品、医保参照药和临床参比药用于不同的评价任务。《参照药预沟通办法（试行）》[42]规定，符合条件的企业可自愿提出申请，由医保局组织专家论证并推荐用于药物经济学或真实世界研究的比较药品，即“参照药”。这为企业提前明确比较药品提供了渠道。

建议在现有申请材料中，按药品及适应症列明研究人群、试验对照药品、主要结局指标和医保参照药的选择理由。医保局申报指南[27]已要求提供药审技术评审报告，可据此说明已有研究与拟开展评价在人群、比较药品和观察结果上的异同，明确哪些结果可以使用、哪些问题需要补充研究。2026 年药品价格政策[43]区分创新类别并强调临床价值，材料中还应分别说明创新药注册分类、相对临床获益和支付评价所依据的证据。药品适应症或临床证据更新时，应相应更新这些信息，以便后续评价使用。

6.2 结合现有评价试点开展补充研究

药监局侧重获益风险证据，医保局侧重相对临床价值及费用影响，卫健委侧重临床使用与供应，补充研究应分别回应这些需要。建议先选择已有明确上市后研究义务或支付评价证据不足的品种，由企业、专业评价团队和参与医疗机构共同拟订补充研究计划，明确研究人群、参照药品、终点、随访期限、数据来源及质量控制要求。可以共用的临床数据按统一字段采集，药物警戒、医保价值评价和临床综合评价仍分别依据各自的目的开展研究设计与分析，并说明结论的适用范围。

《药品注册管理办法》[23]第六十六条已规定附条件批准药品的研究义务。2025 年真实世界医保综合价值评价试点通知[44]提出，2026 年建设数据库、开展评价并形成初步成果；2026 年 1 月，首批

国家可信评价点网络已组建[45]。试点地区医疗保障部门可协调具备相应专科能力的可信评价点参与补充研究。上市许可持有人履行法定的上市后研究义务，其他评价任务按项目约定分工，参与医疗机构负责数据质量和随访。研究开始前，应按照各环节的要求，明确注册研究报告、医保续约及机构药事管理所需结果的提交时间，并记录证据更新情况。

2026 年医保局官方解读[46]区分了医保价值评价与药物警戒、附条件上市确证性试验及临床综合评价的用途。因此，补充研究应针对各环节的问题分别分析；即使共用数据，也应分别说明适用人群、费用范围和参照药品。意大利药品管理局（Italian Medicines Agency，AIFA）监测登记中的按结果支付安排[47]可为试点提供参考。在国内既有协议和支付权限内，应先明确评价结果如何用于续约或管理调整，再讨论相应的费用责任，使新增证据能够用于后续决策。

6.3 完善目录药品配备与使用反馈

按全部句段统计，医保局经济性内容的覆盖比例高于卫健委；而在涉及经济性的表述中，卫健委同时涉及公平性的比例高于医保局。相关条文分别关注费用保障、医疗机构药品供应和临床使用。2025 年基本医保目录与商保创新药目录的发布通知[3]已要求定点机构原则上于 2026 年 2 月底前召开药事管理与药物治疗学委员会会议，并明确药品配备、临时采购和监测责任。建议在现有报送内容中增加药品未配备或患者无法使用的原因，区分无适用患者、证据或用药条件不足、供应延迟和支付衔接等问题。医疗机构药学部门核对临床需求与采购状态，省级卫生健康部门协调医疗机构面临的问题，医疗保障部门处理支付范围及协议执行问题，企业反馈供应情况。

依托既有药品配备查询和省级信息报送渠道，可按药品及适应症汇总配备状态、采购进度、供药渠道和费用保障信息。对于临床急需但尚未常规配备的药品，符合条件的可按现有临时采购或双通道规则处理，并反馈解决情况。基本医保药品应注明支付范围和个人负担比例及适用条件；商保创新药目录中的药品须由保险机构确认具体产品的保障责任，并另列患者自付条件，不能将纳入商保目录等同于基本医保报销[3]。个体资料应按授权和数据管理要求使用，保密价格信息按权限提供。通过补充现有报送字段、明确反馈责任，及时掌握药品纳入目录后患者能否实际获得和使用。

7 结语

本文基于“制度逻辑—组织注意力”框架，结合政策文本编码、条文和访谈分析创新药评价的部门差异。LLM 全量分析显示，药监局侧重安全性与有效性，医保局侧重经济性，卫健委突出安全用药。关注比重还需结合具体评价要求理解：医保局安全性内容占比虽低，相关句段同时涉及有效性的比例却高于另外两部门，与安全有效共同作为医保准入条件的要求相对应。条文与访谈进一步表明，创新药注册分类、临床获益判断和医保支付评价服务于不同决策，相同维度的评价也需区分目标人群、参照药品和证据要求。因此，跨部门协调应明确评价结论的适用条件，提前沟通比较药品的选择与证据要求，结合现有评价试点开展补充研究，并完善目录药品配备与使用反馈。后续可结合评审、药品配备和患者用药资料，考察政策关注重点与实际执行的关系。

补充材料另附完整编码规范、政策来源清单、466 条核验样本构成与分类计数，两种编码方法的全量对照，以及不同统计口径、逐一剔除政策来源和待定项处理下的稳健性检验结果。

参考文献

[1] 中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要[Z].2026.

[2] 国家医疗保障局,国家卫生健康委员会.支持创新药高质量发展的若干措施(医保发〔2025〕16 号)[Z].2025.

[3] 国家医疗保障局,人力资源社会保障部.关于印发《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录》以及《商业健康保险创新药品目录》(2025 年)的通知:医保发〔2025〕33 号[EB/OL].(2025-12-07)[2026-10-08].https://www.nhsa.gov.cn/art/2025/12/7/art_53_18971.html.

[4] 孔繁翠.创新药价值评估的国际经验比较及启示[J].中国卫生政策研究,2022,15(6):17-23.

[5] 赵华婷,颜建周,邵蓉.法国临床效益评价对我国创新药医保目录动态调整的启示[J].中国卫生经济,2019,38(5):94-96.

[6] 艾丹丹,陈辰,吴婷婷,等.价值医疗背景下创新药品的定价和支付模式综述[J].中国卫生经济,2020,39(3):77-79.

[7] 王恩楠,朱铭来.我国专利药品医疗保险价格谈判的演化博弈研究[J].中国卫生政策研究,2023,16(2):44-51.

[8] 吕倩鹏,吴红,刘智勇.政策工具视角下我国创新药物研发政策量化研究[J].中国卫生事业管理,2024,41(12):1393-1399.

[9] CASILLI G, LIDONNICI D, JOMMI C, et al. Do France, Germany, and Italy Agree on the Added Therapeutic Value of Medicines?[J]. International Journal of Technology Assessment in Health Care, 2023, 39(1): e54.

[10] GARAU M, HAMPSON G, DEVLIN N, et al. Applying a Multicriteria Decision Analysis (MCDA) Approach to Elicit Stakeholders’ Preferences in Italy: The Case of Obinutuzumab for Rituximab-Refractory Indolent Non-Hodgkin Lymphoma (iNHL)[J]. PharmacoEconomics Open, 2018, 2(2): 153-163.

[11] KÅLLBERG C, MATHIESEN L, GOPINATHAN U, et al. The Role of Drug Regulatory Authorities and Health Technology Assessment Agencies in Shaping Incentives for Antibiotic R&D: A Qualitative Study[J]. Journal of Pharmaceutical Policy and Practice, 2023, 16: 53.

[12] MUNDY L, FORREST B, HUANG L Y, et al. Health Technology Assessment and Innovation: Here to Help or Hinder?[J]. International Journal of Technology Assessment in Health Care, 2024, 40(1): e37.

[13] 李梦颖,伍琳,王昕妍,等.我国医保谈判药品落地问题的多重制度逻辑分析与政策建议[J].中国药房,2024,35(14):1683-1689.

[14] HE A J, BALI A S, RAMESH M. Active stewardship in healthcare: Lessons from China's health policy reforms[J]. Social Policy & Administration, 2022, 56(6):925–940. DOI:10.1111/spol.12832.

[15] GUO W, WANG P, ZHANG Y, et al. Health Technology Assessment in China's Health Care Sector: Development and Applications[J]. Health Systems & Reform, 2023, 9(3):2327099. DOI:10.1080/23288604.2024.2327099.

[16] 曾润喜,莫敏丽.政府注意力的测量:路径、内容与展望[J].华中科技大学学报(社会科学版),2023,37(1):66-73.

[17] 文宏.中国政府推进基本公共服务的注意力测量——基于中央政府工作报告(1954—2013)的文本分析[J].吉林大学社会科学学报,2014,54(2):20-26,171.

[18] 陈星平,毕利娜,吴道友.中国政府推进科技人才创新创业的注意力测量——中央政府工作报告(1978—2017)文本分析[J].科技进步与对策,2018,35(23):155-160. DOI:10.6049/kjjbydc.L201808216.

[19] 练宏.注意力分配——基于跨学科视角的理论述评[J].社会学研究,2015,30(4):215-241,246.

[20] THORNTON P H, OCASIO W. Institutional logics[M]//GREENWOOD R, OLIVER C, SAHLIN K, et al. The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism. London: SAGE, 2008: 99-129.

[21] GREENWOOD R, RAYNARD M, KODEIH F, et al. Institutional Complexity and Organizational Responses[J]. Academy of Management Annals, 2011, 5(1): 317-371.

[22] OCASIO W. Towards an Attention-Based View of the Firm[J]. Strategic Management Journal, 1997, 18(S1): 187-206.

[23] 国家市场监督管理总局.药品注册管理办法(国家市场监督管理总局令第 27 号)[Z].2020.

[24] 国家医疗保障局.基本医疗保险用药管理暂行办法(国家医疗保障局令第 1 号)[Z].2020.

[25] 国家卫生健康委办公厅.关于规范开展药品临床综合评价工作的通知(国卫办药政发〔2021〕16 号)及附件《药品临床综合评价管理指南(2021 年版 试行)》[Z].2021.

[26] 人力资源社会保障部.关于将 36 种药品纳入国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录乙类范围的通知(人社部发〔2017〕54 号)[Z].2017.

[27] 国家医疗保障局.2026 年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整申报指南[Z].2026.

[28] 国家医疗保障局.国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整常用问答(2026 年版)[Z].2026.

[29] KROON A C, VAN DER MEER T, VLIEGENTHART R. Beyond Counting Words: Assessing Performance of Dictionaries, Supervised Machine Learning, and Embeddings in Topic and Frame Classification[J]. Computational Communication Research, 2022, 4(2):528–570. DOI:10.5117/CCR2022.2.006.KROO.

[30] GILARDI F, ALIZADEH M, KUBLI M. ChatGPT Outperforms Crowd Workers for Text-Annotation Tasks[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2023, 120(30): e2305016120.

[31] HALTERMAN A, KEITH K A. Codebook LLMs: Evaluating LLMs as Measurement Tools for Political Science Concepts[J]. Political Analysis,2026,34(2):188-204. DOI:10.1017/pan.2025.10017.

[32] GRIMMER J, STEWART B M. Text as Data: The Promise and Pitfalls of Automatic Content Analysis Methods for Political Texts[J]. Political Analysis, 2013, 21(3): 267-297.

[33] COHEN J. A coefficient of agreement for nominal scales[J]. Educational and Psychological Measurement, 1960, 20(1): 37-46. DOI:10.1177/001316446002000104.

[34] 国家药品监督管理局药品审评中心.创新药研发期间风险管理计划撰写技术指导原则(试行)[Z].2025.

[35] 国家药品监督管理局药品审评中心.以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则[Z].2021.

[36] 国家药品监督管理局.真实世界证据支持药物研发与审评的指导原则(试行)[Z].2020.

[37] 国家药品监督管理局,国家卫生健康委员会,国家中医药管理局,等.药物临床试验质量管理规范(2026 年修订)[Z].2026.

[38] 国家医疗保障局.谈判药品续约规则[Z].2026.

[39] 国家医疗保障局.国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整常用问答(2025 年版)[EB/OL].(2025-07-10)[2026-10-08].https://www.nhsa.gov.cn/art/2025/7/10/art_109_17198.html.

[40] 国家卫生健康委.关于开展药品使用监测和临床综合评价工作的通知:国卫药政函〔2019〕80 号[EB/OL].(2019-04-09)[2026-10-08].https://www.nhc.gov.cn/yaozs/c100097/201904/6bc8f273684845d3ab76fed841eb42d2.shtml.

[41] 国家药品监督管理局.国家药监局关于发布化学药品注册分类及申报资料要求的通告(2020 年第 44 号)[Z].2020.

[42] 国家医疗保障局.国家医保局发布《参照药预沟通办法(试行)》[EB/OL].(2026-02-10)[2026-10-08].https://www.nhsa.gov.cn/art/2026/2/10/art_109_19642.html.

[43] 国务院办公厅.关于健全药品价格形成机制的若干意见(国办发〔2026〕9 号)[Z].2026.

[44] 国家医疗保障局办公室.关于开展真实世界医保综合价值评价试点工作的通知:医保办发〔2025〕15 号[EB/OL].(2025-09-23)[2026-10-08].https://www.nhsa.gov.cn/art/2025/9/23/art_109_17984.html.

[45] 国家医疗保障局办公室.关于发布真实世界医保综合价值评价国家可信评价点网络公约和成员名单的公告[EB/OL].(2026-01-16)[2026-10-08].https://www.nhsa.gov.cn/art/2026/1/16/art_109_19379.html.

[46] 国家医疗保障局. 2026 年药品目录调整工作方案解读活动文字实录[EB/OL].(2026-05-26)[2026-10-08].https://www.nhsa.gov.cn/art/2026/5/26/art_14_20707.html.

[47] Agenzia Italiana del Farmaco. Registri farmaci sottoposti a monitoraggio[EB/OL]. [2026-10-06]. https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio.